

2022

**RSUD DATU BERU
KABUPATEN ACEH TENGAH
UNIT HUMAS RS**

[Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan]

Manajemen keluhan pelanggan adalah cara yang efektif untuk mengatasi keluhan pelanggan sebagai alat dan konsep dari *total quality management*. Mutu pelayanan yang kurang dapat menimbulkan keluhan bagi pelanggan. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen mutu dan keluhan yang komprehensif dan efektif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan Buku Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati diucapkan sebesar – besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian Buku Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan ini.

Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini.

Semoga Buku Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh staf pegawai di lingkungan UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.

Takengon , 12 September 2022

Penyusun



(N. Himawan , RO , SKM , MH , CPHM)

KATA SAMBUTAN

Buku Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan ini merupakan Pedoman yang di gunakan dalam menangani Keluhan dan Saran yang masuk atau di terima Pihak RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah melalui media dan saluran yang di sediakan, oleh sebab itu saya menyambut baik dan mendukung terbitnya Buku Pedoman Penanganan Pengaduan Keluhan ini. Isi buku ini tidak saja memberikan sumbangan besar bagi penerapan good clinical governance namun juga good corporate governance.

Buku ini di harapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan tata kelola penanganan keluhan di RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah agar setiap individu bisa bekerja secara mandiri , professional serta bertanggung jawab atas citra Rumah Sakit di mata pasien , keluarga dan masyarakat Aceh Tengah.

Selamat membaca dan menerapkannya.

Takengon , 12 September 2022

Direktur



(Dr. H. Gusnarwin , Sp.B)

NIP. 19691029 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DEFINISI.....	1
1.3. TUJUAN.....	2
BAB II RUANG LINGKUP	3
2.1. STRUKTUR ORGANISASI HUMAS RS	3
2.2. PETUGAS PENANGANAN KELUHAN.....	3
2.3. SASARAN PENANGANAN KELUHAN.....	3
2.4. SARANA DAN PRASARANA UNIT HUMAS RS.....	3
BAB III TATA LAKSANA PENANGANAN KELUHAN.....	4
3.1. TATA LAKSANA PENERIMAAN KELUHAN	4
3.2. PENANGANAN KELUHAN BERDASARKAN JENJANG TANGGUNG JAWAB.....	4
3.3. PENANGANAN KELUHAN BERDASARKAN KECEPATAN RESPON	5
3.4. STRATEGI MEREDAM KEMARAHAN PELANGGAN	7
3.3.1. Tindakan yang boleh di lakukan oleh penerima komplain.....	7
3.3.2. Tindakan yang tidak boleh di lakukan oleh Penerima Komplain	9
3.5. STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENANGANAN KELUHAN	10
BAB V DOKUMENTASI	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Lembar Keluhan dan Saran.....</i>	<i>14</i>
<i>Lampiran 2 Lembar Keluhan dan Saran - Media Massa.....</i>	<i>15</i>
<i>Lampiran 3 Lembar Penanganan Keluhan / Saran – Langsung.....</i>	<i>16</i>
<i>Lampiran 4 Lembar Penanganan Keluhan / Saran - Tidak Langsung.....</i>	<i>17</i>
<i>Lampiran 5 Lembar Disposisi</i>	<i>18</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Dahulu fungsi Rumah Sakit hanya untuk menyembuhkan orang sakit, namun pada perkembangannya saat ini telah menjadi suatu pusat kesehatan. Dengan munculnya kebutuhan akan kesinambungan pelayanan dengan perkembangan ilmu, dan teknologi kedokteran, maka fungsi rumah sakit pada saat ini juga telah mencakup pendidikan dan penelitian. Rumah Sakit merupakan lembaga yang dapat menerapkan prinsip bisnis dengan tidak melanggar etika kedokteran dan melindungi orang miskin.

Bila pasien atau konsumen tidak puas atas pelayanan yang diberikan maka kemungkinan terjadi keluhan. Penyampaian keluhan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pihak pemberi pelayanan. Manajemen keluhan pelanggan komprehensif adalah cara yang efektif untuk mengatasi keluhan pelanggan sebagai alat dan konsep dari *total quality management*. Mutu pelayanan yang kurang dapat menimbulkan keluhan bagi pelanggan. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen mutu yang komprehensif dan manajemen keluhan yang efektif.

Unit Humas RS merupakan salah satu pelaksana Manajemen Keluhan melalui kompetensi dan tupoksinya dalam menghadirkan citra RS yang baik di mata masyarakat. Kehadiran Unit Humas di RS diharapkan dapat menjembatani, menyalurkan dan meminimalisir keluhan yang timbul melalui cara perbaikan secara terus menerus terhadap jasa pelayanan kesehatan.

1.2. DEFINISI

Kepuasan pada umumnya dianggap sebagai mediator pusat dari perilaku pasca pembelian, menghubungkan keyakinan produk sebelum dipilih (*prechoice*) terhadap struktur kognitif pasca pemilihan (*postchoice*), komunikasi konsumen, dan perilaku pembelian kembali Liljander (1999). Dengan kata lain, kepuasan konsumen (pasien) dengan penanganan keluhan yang dilakukan karyawan RS dapat menjadu pusat mediator yang menghubungkan persepsi dimensi keadilan dengan sikap dan perilaku pascakeluhan (*postcomplaint*) Sikap dan konsekuensi perilaku dari kepuasan konsumen (pasien) memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan komitmen jangka panjang RS dengan konsumen/pasien (pada khususnya) dan masyarakat (pada umumnya).

1.3. TUJUAN

Pelaksanaan Penanganan keluhan bertujuan untuk :

- a. Menjembatani komunikasi antara pelanggan / pasien dan masyarakat dengan Pihak Manajemen RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Menjadi tolak ukur penilaian mutu pelayanan RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Menjadi dasar perbaikan sarana prasarana yang dinilai kurang oleh pelanggan

BAB II

RUANG LINGKUP

2.1. STRUKTUR ORGANISASI HUMAS RS

- a. Unit Humas RS berada di bawah Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- b. Tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan Direktur No. 188.4/342/UPTD RSU – DB/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada wUPTD RSUD Datu Beru Takengon.

2.2. PETUGAS PENANGANAN KELUHAN

Yang menjadi petugas dalam penanganan keluhan adalah Staf Sub Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di Unit Humas RS serta serta bekerjasama dengan unit-unit terkait dalam menanggapi keluhan.

2.3. SASARAN PENANGANAN KELUHAN

Sasaran kegiatan penanganan keluhan adalah pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang merasa kurang puas dengan pelayanan.

2.4. SARANA DAN PRASARANA UNIT HUMAS RS

- a. Sekretariat
Sekretariat Penanganan Keluhan RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah berada di Unit Humas RS Sub Unit Pengaduan Masyarakat.
- b. Jenis
Jenis peralatan yang dibutuhkan untuk memperlancar penanganan keluhan adalah :
 - 1) Kotak Pengaduan
 - 2) Telepon, untuk mengklarifikasi kepada pelanggan yang komplain
 - 3) Media Sosial akun resmi RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah
 - 4) SMS / Telegram / WhatsApp Pengaduan
 - 5) Lembar Keluhan / Saran
 - 6) Lembar Penanganan Keluhan / Saran
 - 7) Lembar Disposisi
 - 8) Buku Keluhan
 - 9) Buku Ekspedisi
 - 10) Laporan Rekapitulasi Keluhan

BAB III

TATA LAKSANA PENANGANAN KELUHAN

3.1. TATA LAKSANA PENERIMAAN KELUHAN

1. Pasien, keluarga dan pengunjung RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dapat menyampaikan keluhan secara langsung atau tidak langsung. Keluhan secara langsung dapat disampaikan kepada Petugas Jaga di Unit Kerja, Kepala Ruangan, dan Sub Unit Pengaduan Masyarakat. Pasien juga dapat menyampaikan keluhan secara tidak langsung melalui Kotak Pengaduan.
2. Tata laksana penerimaan keluhan yang baik dan berkualitas akan melahirkan kepuasan yang sekaligus menjadi sasaran pelayanan. Agar dapat memuaskan kepada orang yang dilayani, maka petugas harus :
 - a. Bertingkah laku yang sopan
 - b. Menerima keluhan dengan baik dan bersifat netral untuk menenangkan pelanggan yang komplain
 - c. Ramah tamah, selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan

3.2. PENANGANAN KELUHAN BERDASARKAN JENJANG TANGGUNG JAWAB

Penanganan Keluhan dan komplain dari pasien dan pegawai RS akan di lakukan secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

1. Level 1
Pada tingkatan ini, penanganan keluhan atau komplain yang di lakukan di tingkat staf di unit kerja masing – masing. Penanggung jawab penyelesaian masalah keluhan dan komplain ini berada di bawah koordinasi Kepala Tim / Penanggung Jawab Shift yang bertugas pada saat keluhan di terima oleh pasien dan atau keluarga.
Untuk itu semua staf di unit kerja akan di berikan pemahaman dasar tentang bagaimana cara menangani masalah keluhan atau komplain dari pasien dan atau keluarganya.
2. Level 2
Pada tingkatan ini akan menangani keluhan dan komplain yang tidak bisa di selesaikan di tingkat Kepala Tim / Penanggung Jawab Shift sehingga penanganan keluhan dan komplain di bawah koordinasi Kepala Unit Kerja. Kepala Unit kerja akan berusaha menangani permasalahan keluhan dan komplain yang terjadi, menggali kronologis kejadian dan melakukan tindakan dan penyelesaian yang dianggap perlu untuk menyelesaikan keluhan atau komplain pasien dan atau keluarganya.
3. Level 3
Pada tingkatan ini, pihak unit Humas RS akan melakukan mediasi antara pihak Unit Kerja dan pasien dan atau keluarga pasien sebagai pelapor. Pihak

Humas RS akan berupaya mencari win win solution dalam mencari dan memecahkan masalah keluhan atau komplain ini.

Pihak Humas RS akan berupaya memediasi dan meredam agar masalah ini tidak terblow up ke masyarakat. Perkembangan penyelesaian masalah ini akan selalu di laporkan dan berkordinasi dengan Wakil Direktur terkait sesuai dengan kategori masalah dan keluhan yang di hadapi.

4. Level 4

Pada tingkatan ini , penanganan complain di bicarakan di tingkat manajemen RS dengan melibatkan Wakil Direktur terkait untuk di mintai pertimbangan dan solusinya untuk kemudian di sampaikan kepada Pasien / keluarga atau pihak pengaju Keluhan.

Pihak Humas RS akan mengundang pasien / keluarga atau pihak pengaju Keluhan untuk susuk bersama dan di berikan penjelasan mengenai sikap dan jawaban pihak RS.

3.3. PENANGANAN KELUHAN BERDASARKAN KECEPATAN RESPON

Kecepatan Respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah Sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/dampak risiko berupa ekstrim (merah), tinggi (kuning), rendah (hijau) dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko.

1. Keluhan Grading Merah

a. Pengertian

Keluhan Grading Merah adalah keluhan pelanggan yang cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dll.

b. Tata laksana Penanganan Keluhan Grading Merah

- 1) Operasional penanganan saran/keluhan pelanggan dilaksanakan oleh Sub Unit Pengaduan Masyarakat Unit Humas RS;
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana untuk media penerimaan saran/keluhan pelanggan, dengan memasang Kotak Pengaduan dan menyediakan Lembar Keluhan/ Saran pada kotak tersebut di setiap unit pelayanan serta pusat informasi RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;
- 3) Memeriksa Kotak Pengaduan setiap 2 kali dalam seminggu;
- 4) Keluhan / Saran yang bersumber dari media masa dan laporan lisan, selanjutnya juga ditulis pada Lembar Keluhan / Saran;
- 5) Unit Humas RS segera melaporkan keluhan yang bersifat serius seperti berdampak pada aspek *medical legal* atau aspek Hukum kepada Kepala Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- 6) Kepala Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan melaporkan keluhan tersebut kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk ditindaklanjuti oleh Manajemen;

- 7) Semua pihak yang terkait di Manajemen, bersama Komite Medik, membahas dan mengevaluasi keluhan tersebut;
- 8) Setelah rapat dengan pihak terkait, maka keluhan atau dibuatkan kesimpulan kasus keluhan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi;
Rekomendasi ini ada 2, yakni :
 - a. Bersifat internal seperti ada tindakan *punishment* atau sanksi terhadap pegawai atau karyawan yang terkena complain;
 - b. Bersifat eksternal, dengan menindaklanjuti keluhan itu ke pihak terkait yang akan disampaikan oleh Pihak Manajemen.
- 9) Rekomendasi diisikan pada kolom tindak lanjut di Lembar Penanganan / tindak lanjut Keluhan dan dikembalikan kepada Staf Sub Unit Pengaduan Masyarakat;
- 10) Bila sudah selesai masalahnya maka Lembar Penanganan / tindak lanjut Keluhan diberi tanda "**CLOSE**" atau "**C**";
- 11) Tindak lanjut untuk grading merah maksimal dilaksanakan 1x24 jam.

2. Keluhan Grading Kuning dan Grading Hijau

a. Pengertian

Keluhan Grading Kuning adalah keluhan pelanggan yang cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll , sedangkan,

Keluhan Grading Hijau adalah keluhan pelanggan yang tidak menimbulkan kerugian berarti baik secara material maupun inmaterial.

b. Tata Laksana Penanganan Keluhan Grading Kuning

- 1) Operasional penanganan saran/keluhan pelanggan dilaksanakan oleh Unit Humas RSUD Datu Beru kabupaten Aceh Tengah;
- 2) Penyiapan sarana dan prasarana untuk media penerimaan saran/keluhan pelanggan, dengan memasang Kotak Pengaduan dan menyediakan Lembar Keluhan / Saran pada kotak tersebut di setiap unit pelayanan di lingkungan RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;
- 3) Memeriksa Kotak Pengaduan setiap 2 kali dalam seminggu (setiap Senin dan Kamis);
- 4) Saran / keluhan yang bersumber dari media massa dan laporan lisan, selanjutnya ditulis pada Lembar Keluhan/Saran (Media Massa);
- 5) Catat semua Keluhan / Saran yang masuk baik melalui Kotak Pengaduan maupun yang bersumber dari media massa dan atau laporan lisan kedalam Buku Keluhan dan Lembar Penanganan / Tindak Lanjut Keluhan dan Saran;

- 6) Serahkan dan Lembar Penanganan / Tindak Lanjut Keluhan dan Saran kepada Pengadministrasi Umum (staf penerima Surat Masuk di Sub Bagian Umum , Rumah Tangga dan Perlengkapan) untuk diagenda dan diberi Lembar Disposisi;
- 7) dan Lembar Penanganan / Tindak Lanjut Keluhan dan Saran yang telah diberi Lembar Disposisi diserahkan kepada Wakil Direktur sesuai masing-masing permasalahan.
- 8) Bila disposisi telah turun dari Wakil Direktur, segera antarkan 1 berkas Lembar Keluhan (terdiri dari Lembar keluhan / Saran , Lembar Penanganan / Tindak Lanjut Keluhan dan Saran dan Lembar Disposisi) tersebut sesuai dengan isi disposisi;
- 9) Unit Kerja yang terkait mengisi tindakan tindak lanjut yang telah dilakukan pada kolom tindak lanjut di Lembar Penanganan / Tindak Lanjut Keluhan dan Saran dan dikembalikan kepada Staf Sub Unit Pengaduan Masyarakat di Unit Humas RS;
- 10) Staf Sub Unit Pengaduan Masyarakat mengkonfirmasi tindak lanjut dari Unit Kerja kepada pemberi saran / keluhan melalui telepon;
- 11) Bila sudah selesai masalahnya maka lembar penanganan / tindak lanjut diberi tanda "**CLOSE**" atau "**C**".
- 12) Tindak lanjut untuk grading kuning maksimal dilaksanakan 3 hari kerja.
- 13) Tindak lanjut untuk grading hijau maksimal dilaksanakan 7 hari kerja.

3.4. STRATEGI MEREDAM KEMARAHAN PELANGGAN

3.3.1. Tindakan yang boleh di lakukan oleh penerima komplain.

1. Dengarkan.

- 1) Biarkan customer melepas kemarahannya. Cari fakta inti permasalahannya, jangan lupa bahwa pada tahap ini kita berurusan dengan perasaan dan emosi, bukan sesuatu yang rasional. Emosi selalu menutupi maksud customer yang sesungguhnya.
- 2) Dengarkan dengan empati, bayangkan kita berada dalam posisi customer yang lelah, gelisah, sakit, khawatir akan vonis dokter, dll.
- 3) Tatap mata customer dan fokus, jauhkan semua hal yang merintang konsentrasi kita pada customer (telepon, tamu lain, dll).
- 4) Ulangi setiap fakta yang dikemukakan customer, sebagai tanda kita benar- benar mendengarkan mereka.

2. *Berusaha sependapat dengan customer.*

Bukan berarti kita selalu membenarkan customer, namun sebagai salah satu taktik meredakan marahnya customer, kita mencari poin-poin dalam pernyataan customer yang bisa kita setujui.

Misalnya, "Ya Pak, saya sependapat bahwa tidak seharusnya pasien menunggu lama untuk bisa mendapatkan kamar. Tapi saat ini kamar perawatan kami memang sedang penuh, kami berjanji akan mencari jalan keluarnya dan melaporkannya pada Bapak sesegera mungkin".

3. *Tetap tenang dan kuasai diri.*

1) Ingatlah karakteristik customer di rumah sakit adalah mereka yang sedang cemas, gelisah dan khawatir akan kondisi diri atau keluarganya, sehingga sangat bisa dimengerti bahwa dalam kondisi seperti itu seseorang cenderung bertindak emosional.

2) Berhati-hati dengan nada suara, harus tetap rendah, positif dan menenangkan.

3) Jangan terbawa oleh nada suara customer yang cenderung tinggi dan cepat.

4) Sampaikan informasi dengan sopan dan pelan-pelan.

5) Tetap gunakan kata-kata hormat seperti silakan, terima kasih atas masukannya, dan sebut customer dengan namanya.

4. *Mengakui kemarahan customer.*

Gunakan kata-kata seperti :

"Saya mengerti kalau Ibu menjadi marah. Ibu benar, ..

" Kalau saya jadi Ibu, mungkin saya juga akan marah....

" Saya berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari

5. *Permohonan maaf.*

1) Dalam rangka meredakan marah customer, kita harus meminta maaf apapun yang terjadi.

2) Permohonan maaf dapat disampaikan tanpa harus mengakui kesalahan

3) Karena sering kali terjadi kesalahan justru ada pada customer yang belum memahami peraturan.

Misalnya, "Saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini,", "Saya mohon maaf atas kesulitan yang telah Ibu alami".

6. *Perlihatkan empati.*

1) Simpati : Berhenti pada rasa kasihan. "Saya simpati dengan korban bencana alam."

2) Empati : Memahami masalah customer dan berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki.

- 3) Pahami persepsi customer dan tempatkan diri pada posisi customer.

3.3.2. Tindakan yang tidak boleh di lakukan oleh Penerima Komplain.

1. *Jangan berdebat.*
Ingat bahwa saat ini kita masih dalam proses meredakan kemarahan pelanggan / pasien . Kesempatan untuk menjelaskan fakta dan kebenaran akan datang setelah customer reda dan menjadi lebih logis dan rasional.
2. *Jangan bertanya "Kenapa?".*
 - 1) "Kenapa Ibu tidak datang lebih pagi?"
 - 2) "Kenapa kartu pasien Ibu bisa hilang?"
 - 3) Pertanyaan seperti itu cenderung meningkatkan kemarahan customer karena mereka merasa disalahkan.
3. *Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan atau mematuhi persepsi kita.*
4. *Menyalahkan nasabah.*
"Jangan marah-marah dulu dong Bu, Ibu sendiri kan yang datang terlambat,"
5. *Sarkastik (sinis).*
"Bisa saja hal ini kita lakukan, tapi biayanya cukup besar lho Pak,"
6. *Menjelekkan pihak lain.*
"Iya, memang perawat itu orangnya judes."
7. *Memotong pembicaraan customer.*
8. *Memberikan isyarat non-verbal yang berlawanan dengan perkataan (verbal).*
"Ya, saya kan membantu semaksimal mungkin," dengan ekspresi datar atau jemu.
9. *Melempar ke pihak lain.*
"Wah itu urusan bagian billing Bu."
10. *Menggunakan kata-kata klise.*
"Ini peraturan bakunya,". "Rumah sakit lain pasti lebih sulit,"
11. *Hindari humor.*
Humor bisa dilakukan nanti saat masalah sudah selesai dan emosi customer sudah sepenuhnya reda.
12. *Minta dikasihani.*
"Mohon maklum Bu, saya sedang ada masalah keluarga,". "Kalau atasan saya tahu, saya bisa kehilangan pekerjaan,"
13. *Pukul rata masalah dan menganggap complain tersebut adalah hal biasa.*
Customer akan merasa heran karena perusahaan mengambil langkah untuk memperbaiki masalah yang sudah biasa ini.

14. *Mencari-cari kesalahan customer.*

“Ya memang kami lalai begini, tapi kan Bapak juga nggak lapor dulu,”

15. *Memakai istilah teknis yang tidak dimengerti orang awam.*

3.5. STRATEGI MANAJEMEN DALAM PENANGANAN KELUHAN

1. Revitalisasi Manajemen Mutu

Manajemen perlu selalu memotivasi karyawan dengan perbaikan terus menerus. Perbaikan kinerja karyawan perlu memperhatikan *reward system*. Sistem Penghargaan ini penting untuk memotivasi kinerja pegawai. Pihak manajemen perlu membuat kebijakan yang signifikan antara peningkatan pasien dengan peningkatan insentif. Untuk mendukung perbaikan mutu maka diperlukan revitalisasi manajemen mutu. Gugus kendali mutu yang pernah ada di rumah sakit perlu dihidupkan kembali. Pimpinan puncak rumah sakit tidak akan mampu mengendalikan mutu rumah sakit tanpa dukungan semua staf.

2. Hubungan *Public Relation* dengan Wartawan

Tekanan media massa tidak terjadi bila penanganan keluhan dapat diselesaikan pada tingkat pemberi pelayanan atau tingkat Direktur. Pihak manajemen harus proaktif dalam menangani keluhan pelanggan untuk mencegah penyebaran berita buruk. Akan tetapi, penanganan yang dilakukan semestinya tidak hanya memotong mata rantai penyebaran berita buruk, namun juga harus memperbaiki kinerja dari bawah (*bottom up*), meningkatkan pelayanan dan memberikan citra positif. Untuk itu membangun komunikasi dengan Wartawan atau Media sangat diperlukan untuk dapat memfilter keluhan-keluhan agar tidak tersebar dimedia tanpa ada penjelasan yang valid dari Pihak Rumah Sakit.

3. Memecahkan Permasalahan

1) Identify

- a. Tentukan Pokok Permasalahan, coba dapatkan detilnya untuk membantu mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
Cara yang paling efektif adalah dengan bertanya langsung. “Jam berapa appointment yang Ibu buat?”, “Berapa nomor antrian yang Ibu dapatkan?”
- b. Pada akhir pembicaraan seharusnya sudah ada jawaban atas tiga pertanyaan berikut:
 - a) Apa yang terjadi sehingga customer marah?
 - b) Perlakuan apa yang diterima customer?
 - c) Apa yang customer inginkan?

2) Assessment

Pada tahap ini kita sudah memahami permasalahan customer dan sudah bisa membayangkan bagaimana pemecahannya. Yang perlu dipertimbangkan adalah :

- a. Pengaruh munculnya masalah ini pada orang banyak dan pada perusahaan.
- b. Resiko cost: biaya, waktu, tenaga
- c. Ketidaknyamanan customer

3) Negosiasi Win-win solution

4) Action

- a. Proses ini berdasar pada APA dan KAPAN.
- b. Customer harus tahu apa yang akan terjadi pada keluhan mereka setelah mereka menyampaikan keluhannya, dan kapan hal itu akan dilaksanakan.
- c. Tentukan jangka waktu yang realistis, lebih baik kita mempunyai banyak waktu d) Dalam merealisasikan janji kita. Bila ternyata sampai pada deadlinenya janji belum bisa terealisasi, segera hubungi customer dan jelaskan permasalahannya.

BAB V

DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaan penanganan dan pengelolaan keluhan, sarana dan prasarana yang digunakan antara lain:

1. Kotak Pengaduan yang berada di titik-titik pelayanan, yaitu :
 - 1) Di Ruang Tunggu IGD : 1 titik
 - 2) Di Ruang Tunggu Poliklinik : 2 titik
 - 3) Di Ruang Tunggu Instalasi Farmasi : 1 titik
 - 4) Di Ruang Tunggu ICU : 1 titik
 - 5) Di Ruang Laboratorium : 1 titik
 - 6) Di Ruang Tunggu Rengali : 1 titik
 - 7) Di Ruang Tunggu Dedingin : 1 titik
 - 8) Di Ruang Tunggu Pepangil : 1 titik
2. Lembar Keluhan / Saran (FH02a/2022)
3. Lembar Keluhan / Saran - Media Massa (FH02b/2022)
4. Lembar Penanganan/Tindak Lanjut Keluhan dan Saran Langsung (FH03/2022)
5. Lembar Penanganan/Tindak Lanjut Keluhan dan Saran Tidak Langsung (FH04/2022)
6. SPO Persyaratan Penerimaan Pengaduan Keluhan/Saran
7. SPO Penanganan Pengaduan Keluhan Secara Langsung
8. SPO Penanganan Pengaduan Keluhan Secara Tidak Langsung
9. SPO Penanganan Pengaduan Keluhan Pada Jam Kerja
10. SPO Penanganan Pengaduan Keluhan Di luar Jam Kerja
11. Buku Ekspedisi
12. Telepon/ SMS/Telegram/WhatsApp Pengaduan
13. Media Sosial Resmi RSUD Datu beru Kabupaten Aceh Tengah
14. Laporan Rekapitulasi Keluhan/Saran

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, A. (2006) *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara: Jakarta.
Trisnantoro, T. (2005) *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumahsakit*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Sulastono, (2003) *Manajemen Kesehatan*, Gramedia: Jakarta.

Aditama, Y.T, (2004) *Manajemen Administrasi Rumah sakit*, Edisi Kedua, UIP: Jakarta. Bosch, B. G. (2005) *TQM and QFD: Exploiting a Customer Complaint Management System*, Proquest Telecomuncation page: 30.

Sabarguna, B. S. (2004) *Quality Assurance Pelayanan Rumah sakit*, Konsursium Rumah sakit Islam Jateng-DIY: Yogyakarta.

Yamit, Z (2005) *Manajemen Kualitas:Produk & Jasa*, Edisi Keempat, Ekonisia: Yogyakarta. Montes, J.L, Jover, A.V., Fernanders (2003), *Factor Affecting the Relationship between Total Quality Management and Organisasi Performance*, Proquest Telecomuncation page: 188.

Kujala, J., Lillrangk (2004) *Total Quality Management as a Cultural henomenom*, HelsinkyUniversity of Techonologi, Finland [Internet] <<http://www.asg.org>> [Accessed 14 November 2006].

Nasution, M.N, (2005) *Manajemen MutuTerpadu, Total Quality Management*, edisikedua, Ghalia Indonesia: Bogor.

Schibrowsky, J. A., Lapidus, R.S. (1994) *Gainning a CompetitiveAdvantage by Analyzyng Aggregate Complaints*, Academy ResearchLibrary page: 15.

Harrison, L.,J., Walker (2001) *E. Complaining: aContent Analisys ofan Internet Complaint Forum*. Academy Research Library page: 397.

Zinn., J. E., Maldano., R.W., Hamilton (2001) *The Performance Impact of Context in TQM Implementation: the Nursing Facility Industry*. Proquest Telecomuncation page

Lampiran 1 Lembar Keluhan dan Saran



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UPTD RSUD DATU BERU

Jl. Qanira Aini No.133 Kabupaten Takengon
Telp. (0843) 21596-21 (28-Aceh Tengah)



LEMBAR KELUHAN DAN SARAN

Kepada Yth. Direktur RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah
Cq. Kepala Unit Humas RS
Di
Tempat.

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap * :
Alamat :
Telpon / Email* :
Waktu terjadi keluhan* :
Nama Pasien* :
No. RM* :
Tanggal Masuk RS* :
Jam* :

Dengan ini saya menyampaikan Keluhan / Saran antara lain :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Takengon ,

* Harus di isi

NB. Apabila data tidak di isi dengan lengkap ,
maka tidak akan di tanggap

(.....)
Isi nama lengkap

FH 02a/2022

Lampiran 2 Lembar Keluhan dan Saran - Media Massa



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UPTD RSUD DATU BERU

Jl. Qanira Aki No.153 Kecamatan Talingan
Telp. (0643) 21590-21 (28-Aceh Tengah)



LEMBAR KELUHAN DAN SARAN (MEDIA MASSA)

Jenis Media Massa : _____
Nama : _____
Judul : _____
Tanggal Terbit : _____
Inisial Penulis : _____

Isi Ringkas :

Tindak Lanjut :

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum ,
Rumah Tangga dan
Perlengkapan,

Kepala Unit Humas,

Sub Unit Pengaduan
Masyarakat ,

(.....)

(.....)

(.....)

FH 02b/2022

Lampiran 3 Lembar Penanganan Keluhan / Saran – Langsung



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UPTD RSUD DATU BERU
Jl. Qanira Adu No.123 Kabupaten Tegalono
 Telp. (0643) 21596-21126-Aceh Tengah



LEMBAR PENANGANAN / TINDAK LANJUT KELUHAN DAN SARAN (LANGSUNG)

Tanggal :

Identitas Pemberi Saran / Keluhan :

Nama Lengkap * :

Alamat :

Telpn / Email* :

Identitas Pasien :

Nama Pasien* :

No. RM* :

Tanggal Masuk RS* :

Jam* :

Isi :

.....

.....

.....

.....

Tindak Lanjut :

.....

.....

.....

Kesimpulan Pelanggan :

.....

.....

Status Penanganan Keluhan (lingkari salah satu) :

1. Selesai
2. Tidak Selesai ,

Petugas yang menangani,

Petugas Jaga ,

Pelanggan ,

(.....)

(.....)

(.....)

Isi nama lengkap

*** WAJIB DI ISI**

FH 03/2022

Lampiran 4 Lembar Penanganan Keluhan / Saran - Tidak Langsung



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UPTD RSUD DATU BERU
Jl. Qanata Ane No.153 Kecamatan Takengon
Telp. (0643) 21.590-21126- Aceh Tengah



LEMBAR PENANGANAN / TINDAK LANJUT KELUHAN DAN SARAN (TIDAK LANGSUNG)

Tanggal :

Identitas Pemberi Saran / Keluhan :

Nama Lengkap * :

Alamat :

Telpon / Email* :

Identitas Pasien :

Nama Pasien* :

No. RM* :

Tanggal Masuk RS* :

Jam* :

Isi :

.....
.....
.....
.....

Tindak Lanjut :

.....
.....
.....
.....

Kesimpulan :

.....
.....
.....

Status Penanganan Keluhan (lingkari salah satu) :

1. Konfirmasi dengan unit terkait :
2. Konfirmasi / Penjelasan dengan Pelanggan / pasien
 - a. Selesai
 - b. Tidak Selesai ,

Kepala Unit Humas RS

Sub Unit Pengaduan Masyarakat ,

(.....)

(.....)

Isi nama lengkap

. * WAJIB DI ISI

FH 04/2022

Lampiran 5 Lembar Disposisi

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	:	Diterima Tgl.	:
Nomor Surat	:	No.Agenda	:
Tgl. Surat	:		

<u>TUJUAN SURAT</u>	<u>ISI</u>
1. DIREKTUR 2. WADIR ADMINISTRASI UMUM a. KaBag Tata Usaha b. Kabag Keuangan dan Program c. Kabag PSDM 3. WADIR PELAYANAN a. Kabid Pelayanan Medis b. Kabid Keperawatan 4. WADIR PENUNJANG a. Kabid Pengembangan Sarana Penunjang b. Kabid Logistik 5. HUBUNGAN a. Dokter Spesialis/Ummum/Gigi b. Kepala Ruangan c. Kepala Instalasi d. Pengelola ASKES / JKA , Jamkesmas e. KORPRI f.	